La réponse thérapeutique

Classification dynamique de la réponse (ATA) et surveillance après thyroïdectomie totale + iode 131

À RETENIR

- **Réponse excellente** : imagerie normale + Tg **< 0,2 ng/ml** sous LT4 ou **< 1 ng/ml** stimulée → récidive **1–4 %**, décès **< 1 %** ; TSH **0,3–2**.
- **Réponse biologique incomplète** : Tg **> 1 ng/ml** sous LT4, **> 5** sous TSHrh, **> 10** sous stimulation endogène, ou ATg en hausse → **30 %** résolution spontanée, **20 %** maladie morphologique ; TSH **0,1–0,5**.
- **Réponse morphologique incomplète** : **50–85 %** gardent une maladie résiduelle, mortalité **11 %** ; TSH **< 0,1**.
- **Réponse indéterminée** : Tg 0,2–1 sous LT4, 1–5 sous TSHrh, 1–10 endogène, ATg stables → **15–20 %** maladie morphologique ; TSH **0,1–0,5**.
- Régression : ↓ **> 30 %** lésion cible, ↓ **> 25 %** biologique ; progression : ↑ **> 20 %** lésion cible ou nouvelle lésion, ↑ **> 25 %** biologique.
- Surveillance : TSH + Tg sous LT4 à **3 mois** ; Tg stimulée ou Tg ultrasensible + échographie à **6–12 mois**.
- Réponse excellente : suivi tous les **12–24 mois** (TSH, Tg, ATg ± échographie) pendant **10 ans**.

I. Catégories de réponse thérapeutique

Catégorie	Définition	Devenir	PEC
Réponse excellente	① Pas d'anomalie à l'imagerie ② Tg **< 0,2 ng/ml** sous LT4 ou Tg **< 1 ng/ml** après stimulation	**1–4 %** de récidive **< 1 %** de décès	PEC et suivi allégés TSH = **0,3–2**
Réponse biologique incomplète	① Pas d'anomalie à l'imagerie ② Tg **> 1 ng/ml** sous LT4 ; Tg **> 5** sous TSHrh ; Tg **> 10** sous stimulation endogène ; ou ATg en hausse	**30 %** de résolution spontanée **20 %** après traitement complémentaire **20 %** développent une maladie morphologique **< 1 %** de mortalité	Surveillance avec TSH freinée Si ↑ Tg ou ATg : exploration (TDM, TEP…) ou traitement (local +++)
Réponse morphologique incomplète	① Image ⊕ ② Tg ⊖, ATg ⊖ **[à vérifier]** *à vérifier : selon l'ATA, quel que soit le taux de Tg/ATg*	**50 à 85 %** gardent une maladie résiduelle malgré le traitement adjuvant **11 %** de mortalité	Surveillance rapprochée Traitement adjuvant
Réponse indéterminée	① Image non spécifique ② ATg ⊕ mais stables Tg entre **0,2–1** sous LT4 ; Tg entre **1–5** sous TSHrh, **1–10** en stimulation endogène	**15 à 20 %** développent une maladie morphologique Persistance ou diminution spontanée chez les autres **< 1 %** de mortalité	Surveillance biologique et morphologique

II. Critères de réponse

- **Réponse complète** : disparition de toute lésion après traitement spécifique (chirurgie, LT4, IRA-thérapie…).
- **Régression** : diminution de **> 30 %** de la lésion cible et/ou de **> 25 %** biologiquement (Tg, anti-Tg).
- **Progression** (échec thérapeutique) : augmentation de **> 20 %** de la lésion cible ou nouvelle lésion ; augmentation biologique de **> 25 %**.
- **Stabilité** :
  - pas de nouvelle lésion, ni ↑ de **> 20 %** ni ↓ de **> 30 %** de la cible ;
  - pas de ↑ **> 25 %** ni de ↓ **> 25 %** (biologique).
- Selon les critères **RECIST**.
- **ΔSUV** : progression ↑ **> 20 %** ; régression ↓ **> 30 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : PERCIST = variation ≥ 30 % du SUL peak (progression comme réponse)*

NB — Il faut calculer les rapports biologique et morphologique : biologique **25–25 %**, morphologique **30–20 %** (↓ / ↑).

III. Surveillance après TT et traitement adjuvant à l'iode 131

En marge : base [illisible] → clinique – biologie – morphologie ; définition = débattue.

1. TT suivie d'une ablation par ^{131}I.
2. À **3 mois** : TSH et Tg (sous LT4).
3. À **6–12 mois** : Tg stimulée ou Tg ultrasensible + échographie cervicale (EC).

Réponse	Critères	Récidive / TSH cible	Conduite à tenir	Évolution
Excellente	Tg indétectable ; EC normale	Récidive **< 5 %** TSH = **0,3–2**	Diminution de la LT4 ; suivi tous les **12 à 24 mois** : TSH, Tg, ATg ± EC pendant **10 ans**	Tg indétectable
Indéterminée	EC normale ou non spécifique ; Tg ⊕ mais inférieure au seuil institutionnel : Tg **0,2–1** (basale), Tg **1–10** (stimulée)	Récidive **15–20 %** TSH = **0,1–0,5**	Refaire Tg sous stimulation à **1 an** + EC	→ Indétectable ; → détectable mais en ↓ : garder la TSH freinée, contrôle de la Tg à 1 an ; → en augmentation
Incomplète	Biologique : Tg élevée ; morphologique : écho anormale → cytologie + Tg in situ	Récidive **> 20 %** TSH **< 0,1** (morphologique) ; TSH **0,1–0,5** (biologique)	Exploration : TDM, TEP ; traitement : local, ^{131}I, ITK	Tg en augmentation

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définition d'une réponse excellente ?	Imagerie normale + Tg < 0,2 ng/ml sous LT4 ou < 1 ng/ml après stimulation.
2. Seuils de Tg d'une réponse biologique incomplète ?	> 1 ng/ml sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 sous stimulation endogène (ou ATg en hausse).
3. Devenir d'une réponse morphologique incomplète ?	50–85 % gardent une maladie résiduelle ; mortalité 11 %.
4. Risque de maladie morphologique en cas de réponse indéterminée ?	15–20 %.
5. TSH cible selon la réponse ?	Excellente 0,3–2 ; indéterminée/biologique incomplète 0,1–0,5 ; morphologique incomplète < 0,1.
6. Critères de progression ?	↑ > 20 % de la lésion cible ou nouvelle lésion ; ↑ biologique > 25 %.
7. Suivi d'une réponse excellente ?	Diminution de la LT4 ; TSH, Tg, ATg ± EC tous les 12–24 mois pendant 10 ans.